

L'assurance Maladie au Maroc

Pr N TACHFOUTI

Plan

- Introduction
- Financement de la Santé au Maroc
- Historique
- Cadre juridique de la couverture de la couverture médicale au Maroc
- L'assurance maladie obligatoire
 - La CNOPS
 - La CNSS
- Le RAMED

La santé, moteur essentiel du développement économique

- Recommandations OMS suite à la crise financière mondiale (2009) : « empêcher la crise économique de devenir une crise sociale et sanitaire ».
 - préserver les dépenses consacrées à la santé
 - et d'améliorer leur efficacité et leur rendement,
 - accompagner la demande croissante de services publics,
 - mise en oeuvre de réformes des soins de santé primaires.

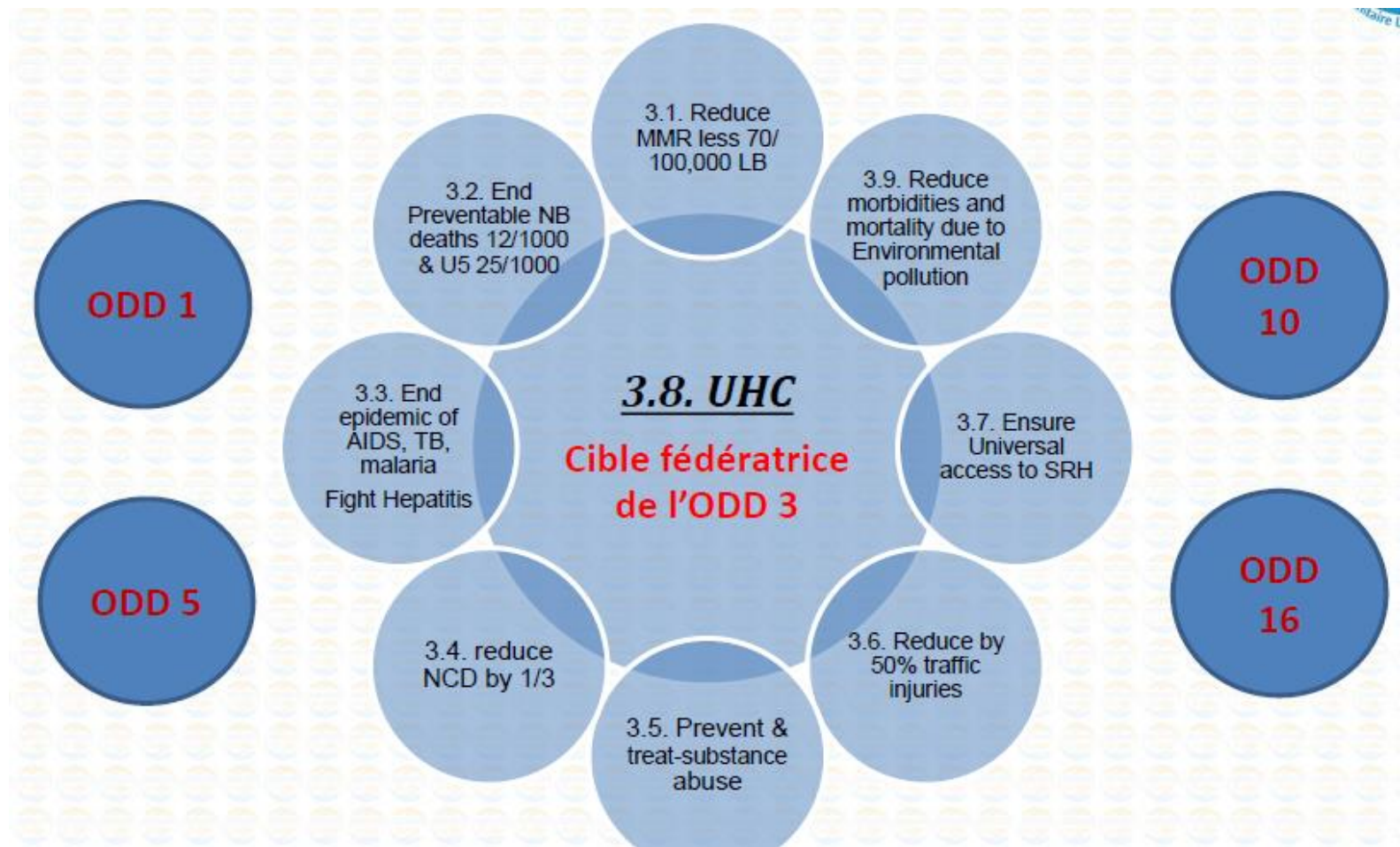
Introduction

- L'article 31 de la constitution 2011 stipule que les citoyens accèdent aux conditions leur permettant de jouir du *droit*
 - aux soins de santé,
 - à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'Etat
 - à l'accès à l'eau et à un environnement sain
 - au développement durable.»

Couverture sanitaire universelle

- **Une Priorité internationale**
- **ODD 3:**
 - **Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous à tous âges**

Couverture sanitaire universelle



Le financement de la santé et ses sous-fonctions

- La collecte des contributions:
 - le moyen par lequel le système de santé reçoit de l'argent des
- La mise en commun des ressources:
 - accumuler et gérer les revenus
 - Répartir le paiement des soins entre les membres
- L'achat:
 - Versement des fonds d'une caisse aux prestataires

Le financement de la santé

- **Les pays riches:**

- le système assure une couverture de soins universelle
 - Impôts et assurance sociale, évitant aux ménages de payer de leur poche les soins.

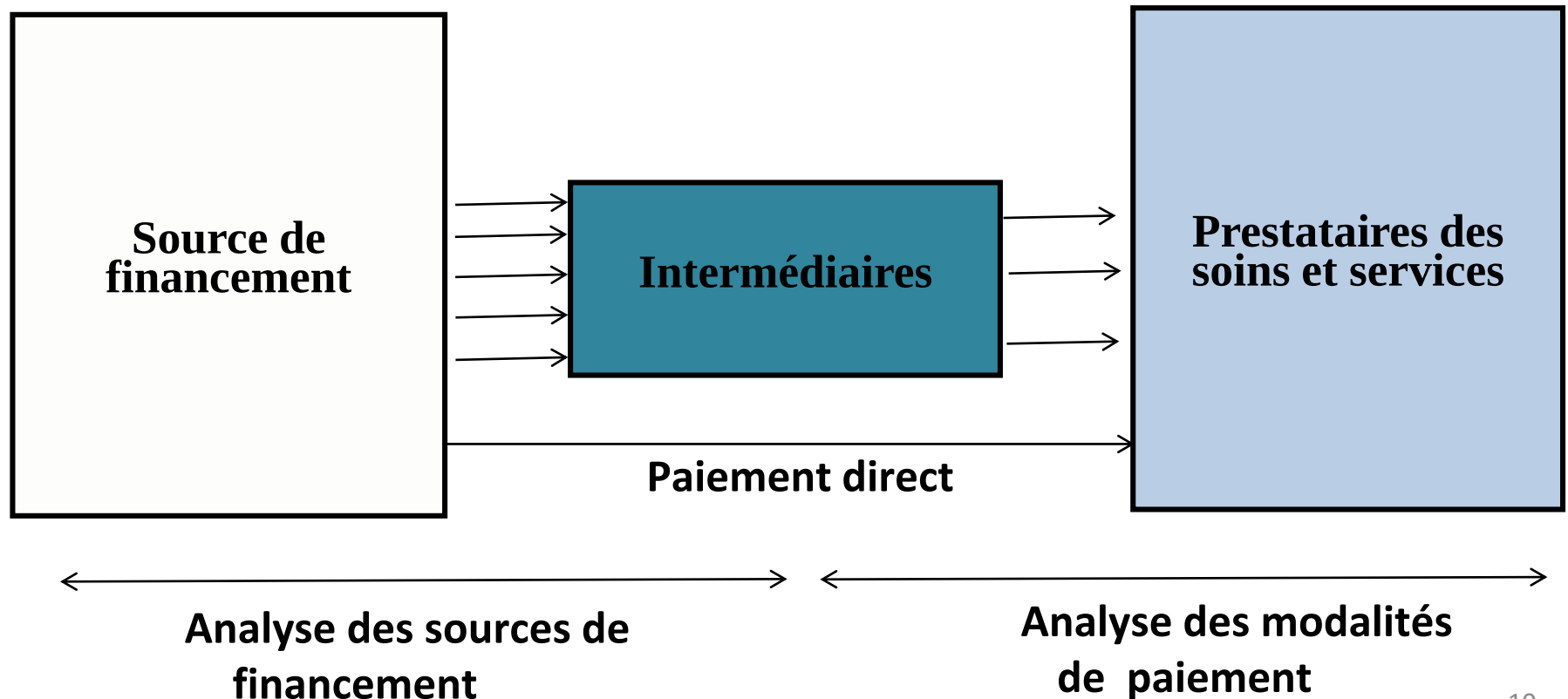
- **Les pays pauvres:**

- Les ressources gouvernementales limitées,
- les ménages contribuent souvent directement au financement de la santé en payant les soins
 - système de tarification à la charge des utilisateurs

Acteurs du financement

- **Financeurs du système :**
 - Ménages, Entreprises, Extérieur
- **Intermédiaires de financement :**
 - Etat/MS, Assurances, sécurité sociale..
- **Prestataires de soins et services de santé :**
 - Hôpitaux, centres de santé, cliniques, pharmacies, programmes de santé;
- **Consommateurs de soins et services:**
 - Population

Principales composantes du dispositif de financement



Sources du financement et modalités de paiement

- **Sources de financement :**
 - **Sources publiques :**
 - fiscalité, emprunts, dons, création monétaire ;
 - **Sources parapubliques :**
 - cotisations obligatoires patronales et salariales;
 - **Sources privées :**
 - paiements directs des ménages, mutuelles de santé et assurances privées.
- **Modalité de paiement:**
 - Rémunération à l'acte, rémunération au cas, forfait journalier, capitation, salaire, budget global, budget par poste.

Dépenses globales de santé DGS

- 2013: La DGS : 52 milliards MAD.
 - 1 578 Dirhams par habitant, soit 5,8% du PIB (982 Milliards MAD)
- En 2010: La DGS : 47,8 milliards de Dirhams
 - 1 498 Dirhams par habitant
 - La DGS représente à peine 6,2% du PIB contre 5,3% en 2006.
- La DGS a enregistré une évolution annuelle moyenne de 11,8% entre 2006 et 2010

Dépenses globales de santé DGS

- DTS au Maroc en 2018 : 60,9 milliards MAD
- 52 milliards en 2013
- un accroissement global de l'ordre de 17,1% et une augmentation annuelle moyenne d'environ 3,2%.
- 5,5% du PIB contre 5,8% en 2013
- 1730/hab (184 US&)

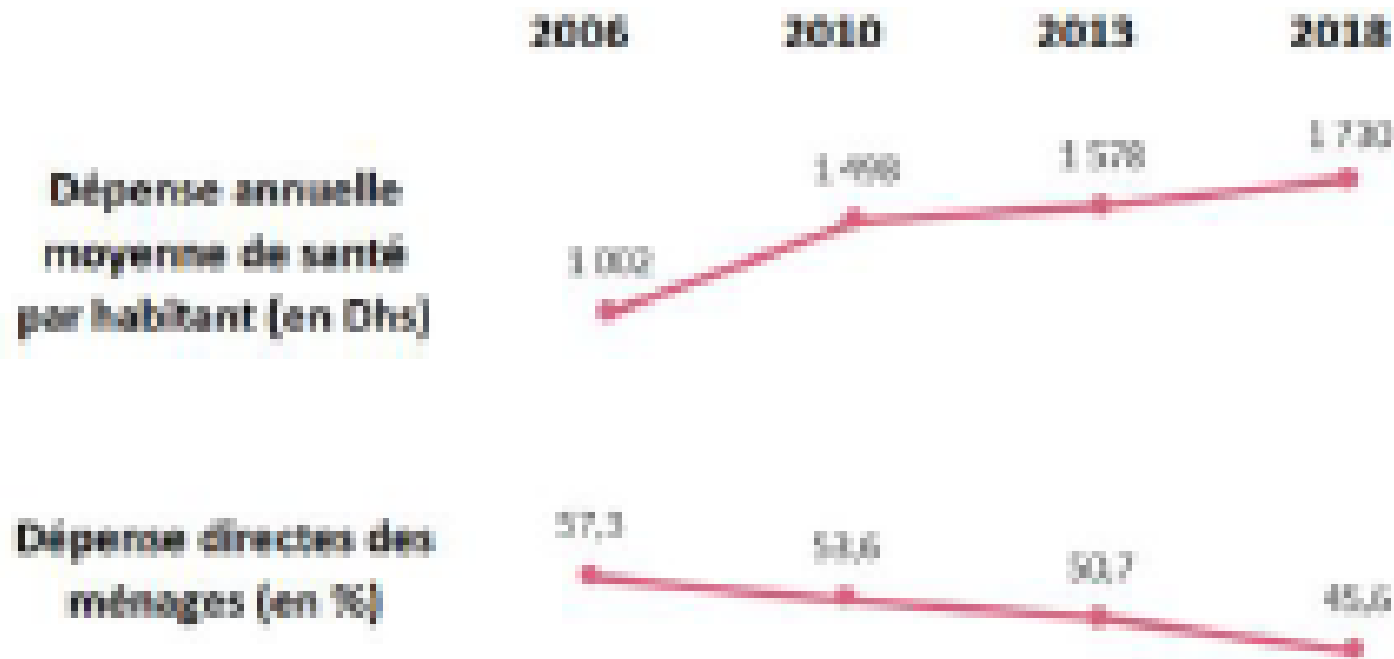
Evolution des dépenses de la santé

- La part de DTS dans le PIB
 - Compare: dynamique de DS et accroissement du PIB,
 - comparaisons internationales.
- Pour la Maroc, 6,2% en 2010 à 5,8% en 2013.
 - Moyenne des pays de l'OCDE (8,9%).

Dynamique des DTS au Maroc entre 2006 et 2018



Dynamique des DTS au Maroc entre 2006 et 2018



Dépenses globales de santé DGS

- la DGS en 2018 au Maroc est financée par :
 - Paiement direct des ménages : 45,6%
 - 50,7% en 2013 (Normes OMS: 25%)
 - La couverture médicale : 29,3% (23,2% en 2013)
 - (40,6% de la population marocaine couverte)
 - Les ressources fiscales : 24,0% (similaire en 2013)
 - La coopération internationale : 0,2%
 - Les autres sources : 0,5%.

Dépenses globales de santé DGS

- Architecture des dépenses par fournisseur
 - Pharmacies et fournisseurs des biens médicaux: 23,4%
 - Etablissements publics de santé (CHU, hôpitaux et ESSP): 22%
 - Cliniques privées et cliniques mutualistes: 18,9%
 - Soins ambulatoires privés: 15,3%
 - Laboratoires et centres de radiologie; 12%
 - Autres: 8,3%

Dépenses globales de santé DGS

- Architecture des dépenses par type
 - Dépenses hospitalières: 30%;
 - Ambulatoires curatives et préventives: 28,7%;
 - Achat des médicaments et biens médicaux: 23,4%;
 - Analyses et radiologies: 11,7%

Dépenses globales de santé DGS

Pays	PIB par habitant (dollar international)	Dépense de santé par habitant (dollar international)	Dépense de santé par rapport au PIB (%)	Paielements directs des ménages (%)
Turquie	28 545	1 171	4,1	17,5
Egypte	11 366	614	4,9	62,3
Maroc (*)	7 438	489	5,5	45,6
Iran	13 472	1 691	8,7	35,8
Liban	15 612	1 086	8,3	33,2
Algérie	11 642	963	6,2	32,6
Jordanie	10 023	738	7,8	33,2
Tunisie	11 764	912	7,3	38,9
France	45 561	5250	11,3	9,2
USA	61 498	10 624	16,9	10,8

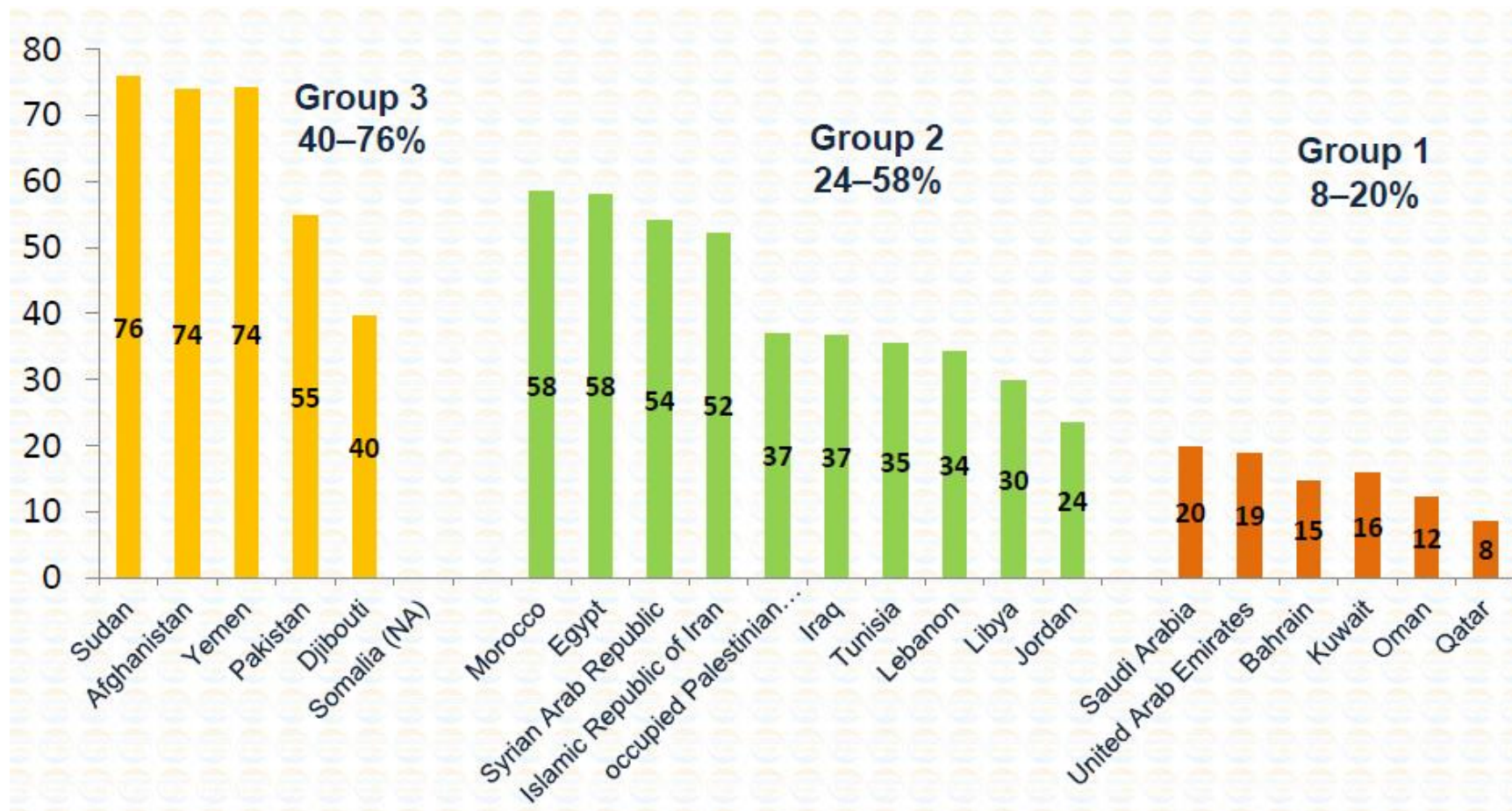
Budget du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

- Budget général du Ministère de la santé et de PS en 2021: 19 774 145 000 MAD
 - 6.53% du budget général de l'état
 - 1.54% du PIB

Dépenses de santé par habitant et par pays de la région EMRO, 2013



Part des dépenses directes des ménages dans les dépenses totales de santé EMRO, 2013



Niveau de la dépense en santé : comparaison avec quelques pays, 2013

Pays	PIB par habitant (dollar international) ⁵	Dépense totale de santé par personne (dollar international) ⁶	Dépense totale de santé par rapport au PIB ⁷ (%)	Dépense directe des ménages par rapport à la dépense totale de santé ⁸ (%)
Turquie	18 701	1 007	5,4	16,8
Egypte	10 383	567	5,5	56,2
Maroc CNS	7 575	436	5,8	50,7
Maroc OMS	7 224	429	5,9	59,2
Iran	16 095	1 045	6,5	47,1
Liban	15 573	1 033	6,6	37,5
Algérie	12 055	859	7,1	26,4
Jordanie	10 550	763	7,2	22,5
Tunisie	10 978	797	7,3	36,4
France	37 801	4 370	11,6	6,4
USA	53 190	8 988	16,9	11,5

Source : OMS, Banque Mondiale, CNS élaborés par le Maroc.

Recommandation OMS

- Pour atteindre les ODD en matière de santé
- Les investissements doivent augmenté la proportion du PIB consacrée aux dépenses de santé dans 67 pays concernés en moyenne de 5,6% à 7,5%.
- La moyenne mondiale des dépenses de santé en proportion du PIB s'établit à 9,9%

Historique

- **L'assurance maladie au Maroc était facultative (avant l'AMO et RAMED)**
 - Elle ne couvrait que 30% de la population Marocaine dont la majorité était citadine.
 - Plus des deux-tiers de la population couverte se composaient des agents de l'État ou assimilés ainsi que leurs ayants droit.
- **Pour les économiquement faibles :**
 - aucune couverture médicale n'était disponible.
 - Prise en charge (quasi-gratuitement) dans les structures de soins publiques
 - **Certificat d'indigence**

Historique

- **L'assurance maladie au Maroc est facultative (avant l'AMO et RAMED)**
- A cette fin, un système obligatoire de couverture médicale de base est mis en place en vue d'atteindre l'accès universel aux soins.
 - le principe *contributif* et la mutualisation des risques

Historique

- 2000: 1^{ière} loi d'assurance maladie obligatoire: Loi 65-00: code de couverture médicale de base
- septembre 2003: Publication du décret : agence nationale de l'assurance maladie(ANAM);
- 2005: Début effectif
 - Assurance Maladie Obligatoire (AMO)

Cadre juridique de la couverture médicale au Maroc

- La loi 65-00:
 - universalisation de couverture maladie au Maroc.
 - Concrétise l'engagement de l'Etat,
 - droit à la santé selon les conventions internationales
 - Parachèvement de l'expérience de couverture médicale
 - Consolidation des droits acquis par les bénéficiaires d'une assurance maladie.

- Reforme du financement de la santé
 - 2002: loi cadre 63- 00 portant code de la couverture médicale de base
 - Objectif: égalité et équité dans l'accès au soins
 - Préoccupation majeure: efficience dans le financement

Historique

- 2008: Lancement du RAMED (région Tadla-Az)
 - dans le cadre d'une expérience pilote
- 2012: Généralisation du RAMED
- 2016: MEO de l'AMO au profit des étudiants
- 2017: publication de loi 98-15 de couverture médicale des travailleurs non-salariés
 - Généralisation en cours

Faits marquants

- Discours Royal du juillet 2018 à l'occasion de la fête du Trône où SA MAJESTE a appelé à «Redresser les anomalies qui entachent l'exécution du programme de couverture médicale Ramed et, parallèlement, refondre en profondeur le système national de santé, qui se caractérise par des inégalités criantes et une faible gestion »

Faits marquants

- 14 avril 2021: cérémonie de lancement de la mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale présidée par SA MAJECTE au palais Royal de Fès, avec la signature des premières conventions y afférentes.

Couverture de la population Marocaine en 2020

- 70,2% de la population Marocaine est couverte: 25,2 M
 - AMO: 11,7 M
 - RAMED: 11 M

Faits marquants

- Discours Royal du 29 juillet 2020 : SA MAJESTE a annoncé le lancement du chantier social de la généralisation de la couverture sociale à partir de Janvier 2021
 - *généralisation de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des allocations familiales.*
 - *Il sera ensuite étendu aux autres couvertures sociales que sont la retraite et l'indemnité pour perte d'emploi*

Adoption de la loi cadre sur la protection sociale 09/21 en 2021

- Elargir la CMO à l'ensemble des marocains en 2022, soit 22 millions de bénéficiaires supplémentaires de l'AMO.
- Généraliser les allocations familiales à 7 MM d'enfants en âge de scolarisation en 2022

Adoption de la loi cadre sur la protection sociale 09/21 en 2021

- A horizon 2025 l'élargissement de la base de cotisation aux régimes de retraites pour intégrer 5 millions de personnes de la population active qui ne disposent d'aucune couverture retraite.
- Ainsi que la généralisation de l'indemnité perte d'emploi à l'ensemble des personnes ayant un emploi stable.

Coût de la reforme sociale

- la mesure prévue pour deux ans devra générer 5 Mds de DH par an (au total 10 Mds de DH),
- alors que le financement de la généralisation de la protection sociale est estimé à 14,5 Mds de DH, selon le ministre des Finances.

Cadre juridique de la couverture médicale au Maroc

- a confié la gestion de l'AMO aux organismes gestionnaires suivants:
 - La CNSS, pour les personnes assujetties au régime de sécurité sociale, les retraités et leurs ayant du secteur privé ;
 - La CNOPS pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, les retraités et leurs ayant

Cadre juridique de la couverture médicale au Maroc

- Le législateur a institué un établissement public l'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM) afin de veiller sur le bon fonctionnement de l'application du dispositif.

Cadre juridique de la couverture médicale au Maroc

- l'ANAM a pour missions
 - Assurer l'adéquation entre le fonctionnement de l'AMO et les objectifs de l'Etat en santé;
 - Conduire les négociations des conventions entre organismes gestionnaires et prestataires de soins;
 - Encadrer et réguler le système de l' AMO,
 - veiller à l'équilibre entre ressources et dépenses de chaque régime d'AMO
 - Gérer les ressources du RAMED.

Cadre juridique de la couverture médicale au Maroc

- **A retenir**
- un système obligatoire de couverture médicale de base (AMO) et un Régime d'assistance Médicale sont mis en place respectivement en 2005 et 2011,
 - Pour atteindre l'accès universel aux soins.
- L'État devait veiller à l'équilibre financier à travers l'encadrement permanent du système de couverture.

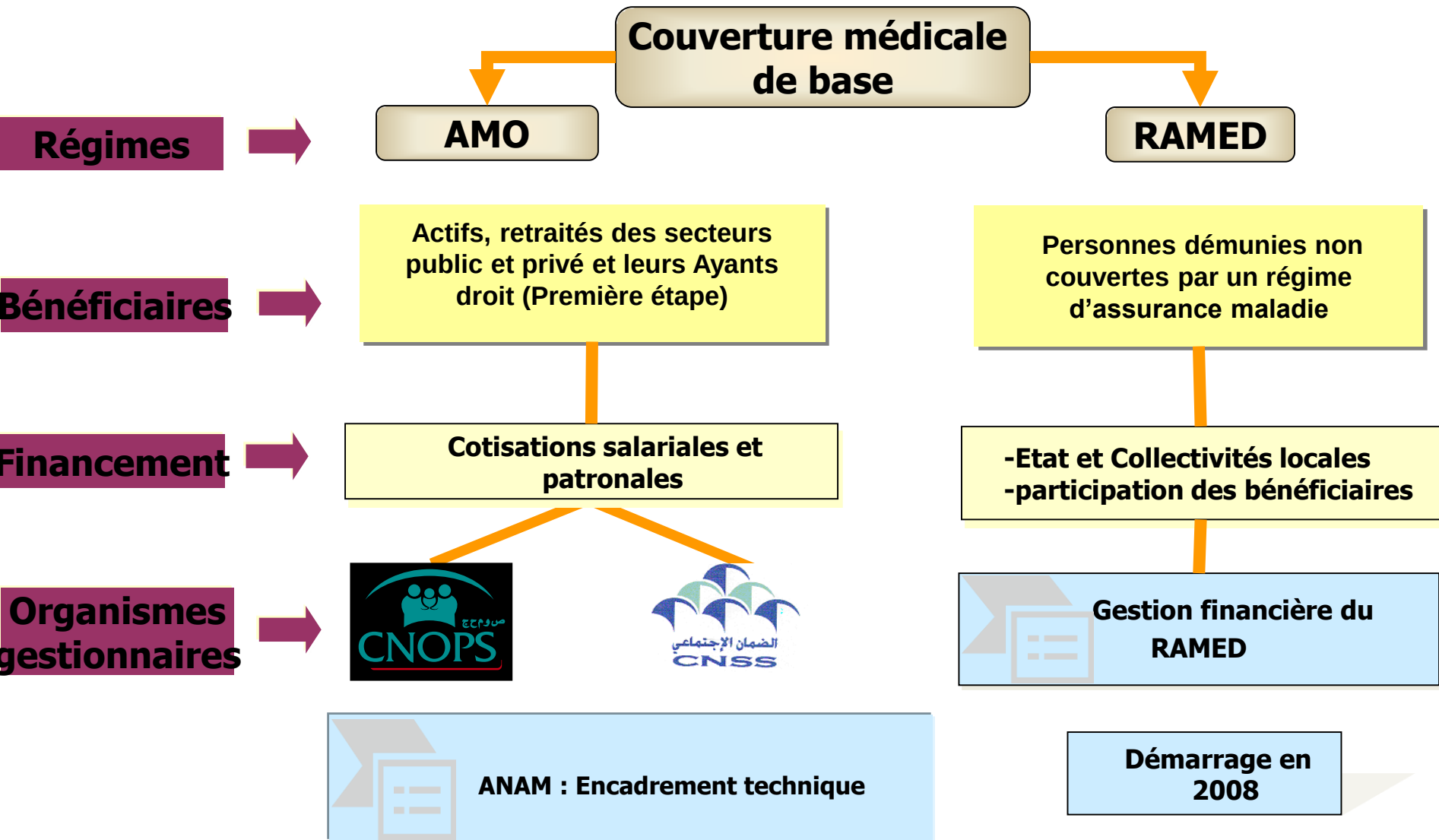
Cadre juridique de la couverture médicale au Maroc

- Les deux régimes ont couvert en 2013 environ 50 % de la population Marocaine (16.5 Millions)
 - 14 millions étaient couverts à la fin de fin 2013.
 - 2.5 millions d'éligibles au RAMED en cours
- Ce pourcentage s'élèvera avec la mise en place d'autres régimes d'AMO à savoir :
 - Le régime d'étudiants en couvrira près de 500000
 - Celui des travailleurs indépendants, qui devra profiter à 30% de la population marocaine.

Cadre juridique de la couverture médicale au Maroc

- Population marocaine bénéficiaire de la Couverture Médicale
 - 16% avant 2005 (date d'entrée en vigueur de l'Assurance Maladie Obligatoire) à
 - 66% en 2018
 - 35% AMO
 - 31% RAMED
 - il est prévu qu'il atteigne les 95 % après l'entrée en vigueur du projet de loi 98- 15 relatif au régime d'AMO des travailleurs indépendants.

Organisation générale de la couverture médicale



D'autres catégories auront prochainement une couverture : **les auxiliaires de l'autorité, les imams de mosquées, les travailleurs indépendants, etc.....**

L'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE

- L'AMO couvre les catégories suivantes:
 - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics;
 - les personnes assujetties au régime de sécurité sociale en vigueur dans le secteur privé;
 - les titulaires des pensions des deux secteurs public et privé ;
 - Leurs ayants droit
 - 12/2022: Ramedistes (basculement vers CNSS)

L'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE

- Sont considérés comme employeurs affiliés d'office au titre de l'AMO:
 - les employeurs affiliés à la CNSS au titre des prestations de sécurité sociale;
 - les administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics dont les fonctionnaires et agents sont immatriculés à la CNOPS;
 - les organismes gérant les régimes de pensions.

L'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE

- Etape suivante de généralisation: couverture maladie au profit des
 - étudiants de l'enseignement supérieur public et privé et aux travailleurs indépendants,
 - personnes exerçant une profession libérale
 - toutes autres personnes exerçant une activité non salariée sur la base du principe de la progressivité.

L'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE

- En 2018: 31% de la population Marocaine
- Population de l'AMO en 2015: 8,7 Millions de bénéficiaires
 - 5,7 Millions de bénéficiaires au secteur privé.
 - 3,0 Millions de bénéficiaires au secteur public.
- Evolution annuelle moyenne de 6,2% entre 2006 et 2015.

Généralisation de la couverture médicale: loi 09/21

- 01/12 /2022: Ramedistes basculent vers l'AMO
 - **Près de 11 Millions de bénéficiaires**
 - Immatriculation automatique à la CNSS
 - L'État prend en charge les cotisations de citoyens incapables de s'en acquitter
 - Continuité de gratuité de prestations du secteur publics;
 - Remboursement partiel dans le secteur privé,
 - médicaments, analyses, radio selon le panier de soins et taux en vigueur

Avantages du basculement

- Ayants droit
 - Conjoint
 - Enfants ≤ 21 ans et 26 ans s'ils sont scolarisés
 - Enfants handicapés sans limite d'âge
- Taux de remboursement
 - 70% de la tarification de référence
 - 70 à 100% : ALD et affections lourdes et coûteuses
 - 100%: soins à l'étranger non disponibles au Maroc

**Vous étiez bénéficiaire du RAMED,
à partir du 1^{er} décembre 2022,
vous bénéficierez automatiquement de l'AMO**



حماية وحدة تجمعنا



www.cnss.ma



05 20 19 40 40



AMO: situation financière (2018)

- Cotisations et contributions: 12 374 millions MAD
- Le secteur privé contribue de 59%
 - effectif de ses assurés 2,5 fois ceux du secteur public
- Frais engagés: 13 627 millions MAD,
 - 8 923 millions de Dirhams dépensés par les organismes gestionnaires de l'AMO soit 65,5%

Population et dépenses de l'AMO

Population de l'AMO fin 2018 :28.6% de la population

10,1 millions de bénéficiaires de l'AMO, dont :

- **7,0 millions** de bénéficiaires au secteur privé.
- **3,1 millions** de bénéficiaires au secteur public.

Évolution annuelle moyenne de **4,6%** entre 2013 et 2018.

Âge moyen des bénéficiaires du Privé de **29,2 ans**.

Âge moyen des bénéficiaires du Public de **34,6 ans**.

Dépense de l'AMO 2018

8,9 milliards de Dirhams de dépenses en 2018.

- **4,0 milliards** de Dirhams concernent le secteur privé ;
- **4,9 milliards** de Dirhams concernent le secteur public.

31,5% des dépenses sont destinées aux médicaments.

51,5% des dépenses sont effectuées par les personnes touchées par une Affection de Longue Durée.

Évolution annuelle moyenne de **10,5%** entre 2013 et 2018.

LA CNOPS

- Depuis l'entrée en vigueur de la loi 65-00, la CNOPS est l'organisme gestionnaire d'AMO pour les agents et retraités du secteur public.
- La CNOPS gère également la couverture médicale au profit des anciennes victimes des droits de l'Homme pour la période comprise entre 1956 et 1998, suite à une convention signée avec l'Etat et le CCDH.

La CNOPS

- A ce titre, la **CNOPS** se charge de :
 - Conclure des conventions nationales avec les prestataires de soins .
 - Etablir des comptes relatifs à la gestion de l'AMO.
 - Assurer le recouvrement des cotisations salariales et contributions patronales
 - Assurer le contrôle médical en coordination avec les sociétés mutualistes concernées.

LA CNOPS

- **sont chapeautées par la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS, 1963) qui gère pour leur compte l'assurance maladie du secteur commun**
 - **Risque vieillesse, accident, invalidités**
 - **Remboursement des frais médicaux**
 - **Gestion d'œuvres sociales**

LA CNOPS

- Le taux de la cotisation due à la CNOPS
 - 5 % de l'ensemble des rémunérations
 - répartis à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
 - Concernant les titulaires de pensions,
 - 2,5 % du montant global des pensions de base servies
- Pour tout nouveau fonctionnaire ou titulaire de pension, l'employeur est tenu d'adresser à la CNOPS, une demande d'immatriculation

I - Les mutuelles des agents publics et assimilés

(CNOPS, 1963)

- Enseignement (MGEN)
 - Administration Centrale et Collectivités Locales (Mutuelles Générales des personnels des administrations marocaines, Mutuelles des Œuvres Mutuelles des fonctionnaires des Administrations Marocaines).,
 - Forces Armées Royales, (Mutuelle des FAR)
 - Poste (Mutuelle Générale des Postes et des Télécommunications)
 - Forces Auxiliaires (Mutuelle des forces auxiliaires)
 - Police (La fraternelle de la police nationale)
 - Office d'Exploitation des Ports
 - Douanes (Mutuelle des Douanes)
- Ces mutuelles couvrent les salariés et les retraités ainsi que leurs ayants droit.

LA CNOPS

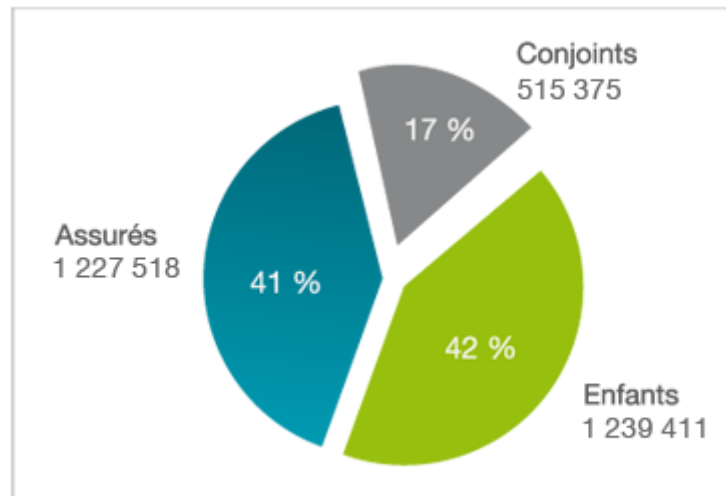
- Les Mutuelles continuent de gérer le régime complémentaire à côté de l'AMO. Elles ont pour missions de :
 - Réceptionner, traiter, contrôler et liquider les dossiers relatifs aux soins ambulatoires.
 - assurer une couverture complémentaire;
 - Gérer les œuvres sociales au profit des adhérents et certaines prestations complémentaires : prime de décès, prime de retraite, scolarisation des enfants handicapés

LA CNOPS

- **A ne pas oublier :**
 - **La CNOPS** est responsable du régime d'assurance maladie obligatoire : précompte, immatriculation, prise en charge, remboursement, contrôle médical.
 - **Les mutuelles** réceptionnent les dossiers de maladie relatifs aux soins ambulatoires, les traitent, les contrôlent et les présentent à la CNOPS pour paiement.

LA CNOPS

- Le nombre des bénéficiaires de la CNOPS a atteint en 2013, 2.982.304 personnes dont 1.227.518 assurés et 1.754.786 ayants droit.



Les mutuelles internes

Les mutuelles internes (régimes internes) sont des assurances maladie offertes et gérées par des Établissements et Entreprises Publics (OCP, ONCF, CNSS, RAM, Régie des Tabacs, Bank Al Maghreb, Banque Populaire...) au profit de leurs employés.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

- La CNSS gère le seul régime obligatoire de sécurité sociale à caractère général au Maroc.
- Ce régime couvre les salariés de l'industrie, du commerce et des professions libérales ainsi que ceux de l'agriculture et de l'artisanat.
- Il leur assure une protection contre les risques de suppression de revenus en cas de maladie, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse.
- Couverture médicale des ex RAMEDistes à partir de Décembre 2022

LA CNSS

- C'est en 1959 qu'a été institué le régime de sécurité sociale des salariés de l'industrie, du commerce et des professions libérales. Il a pour mission de
 - protéger les assurés sociaux contre les risques de suppression de leur revenu en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de vieillesse,
 - leur servir des allocations familiales
 - attribuer à leurs ayants-droit, une allocation de décès et une pension de survivants.

LA CNSS

- Entré en vigueur le 1er avril 1961, ce régime a été étendu, depuis, aux secteurs de l'agriculture et de l'artisanat.
- Il a, par ailleurs, connu des améliorations et extensions des prestations servies et la mise en place d'un réseau d'établissements sanitaires sous forme de polycliniques.
 - 13 polycliniques (1000 lits)

LA CNSS

- Les employeurs assujettis à ce régime doivent, d'une part, verser une cotisation assise sur l'ensemble de la rémunération mensuelle octroyée aux salariés à raison de
 - 50% à leur charge
 - 50% à la charge du salarié.

La Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM)

La Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM) couvre essentiellement des employés des grandes entreprises travaillant dans les secteurs des Banques et des hydrocarbures.

Régime d'assurance maladie obligatoire pour les étudiants

- La gestion :CNOPS,
- L'encadrement : Ministère de la Santé, l'ANAM avec la contribution de:
 - l'Office National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles (ONOUSC),
 - l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).
- contribution annuelle
 - L'état se charge de la des étudiants du secteur public
 - Les étudiants du secteur privé payeront 400 dirhams

Régime d'assurance maladie obligatoire pour les étudiants

- Sont soumis au régime de l'AMO de base des étudiants, les étudiants Marocains et étrangers:
 - des établissements de l'enseignement supérieur relevant des universités;
 - des établissements de l'enseignement supérieur ne relevant pas des universités;
 - dans les établissements des classes préparatoires aux grandes écoles – public et privé;
 - Dans les établissements de formation professionnelle – public et privé;

- **Les conditions d'éligibilité :**
 - Etre inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle;
 - Etre âgé de 30 ans au maximum
 - Ne pas être bénéficiaire d'une autre couverture médicale personnel ou en tant qu'ayant droit :
 - Le RAMED;
 - L'AMO secteur public gérée par la CNOPS;
 - L'AMO secteur privé gérée par la CNSS;
 - Les Mutuelles ou les caisses internes relevant des établissements publics

Régime d'assurance maladie obligatoire pour les étudiants

- Lancé en Janvier 2016
 - par la mobilisation d'une enveloppe budgétaire de 110 millions de dirhams.
- **300 000 étudiants assurés en 2021**

Le RAMED:

Régime d'assistance médicale

- Lancé en novembre 2008 dans le cadre d'une expérience pilote dans la région Tadla-Azilal
- Lancement de l'opération de sa généralisation par Sa Majesté le 13 Mars 2012

Le RAMED: principe et éligibilité

- Le RAMED est fondé sur le principe de l'assistance sociale et de la solidarité nationale au profit de la population démunie *non éligible à l'AMO*
- Les personnes en situation de pauvreté bénéficieront gratuitement du régime d'assistance médicale,
- Celles en situation de vulnérabilité devront payer 120 dirhams par personne sans dépasser 600 dirhams par foyer.

Le RAMED: principe et éligibilité

- les personnes visées à l'article **116 de la loi n° 65-00** doivent remplir deux conditions suivantes :
 - Attester qu'elles ne bénéficient d'aucun régime d'assurance maladie obligatoire soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit,
 - Etre reconnues, sur la base des critères d'éligibilité prévus selon le milieu de résidence, qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes aux soins.

RAMED: PANIER ET FILIERE DE SOINS

- Panier de soins: mêmes prestations couverte par l'AMO
 - Préventive, curative et de de réadaptation
 - Prestations médicalement requises et disponibles dans les centres de santé, les hôpitaux locaux, les hôpitaux provinciaux, préfectoraux, régionaux et universitaires, selon le niveau des prestations que ces établissements offrent.
 - Sont exclus les interventions de chirurgie esthétique.

RAMED: PANIER ET FILIERE DE SOINS

- La prise en charge des prestations couvertes par le RAMED se fait exclusivement dans les structures publiques de santé (la prise en charge à l'étranger est exclue)
- Les personnes assurées par les deux régimes (RAMED et AMO) doivent être couverts sans discrimination aucune due à l'âge, au sexe, à la nature de l'activité, au niveau et à la nature de leur revenu, aux antécédents pathologiques ou à leurs zones de résidence.

RAMED: PANIER ET FILIERE DE SOINS

- En dehors des situations urgentes, l'admission aux établissements de santé des RAMEDistes a lieu selon la *filière de soins* suivante :
 - Porte d'entrée obligatoire : Le CS de rattachement au domicile du bénéficiaire, dont le nom est inscrit
 - En cas de besoin, le médecin du CS réfère à l'hôpital le plus proche et la plus adaptée dans la filière de soins au sein de la province :
 - Si les prestations ne sont pas disponibles, le médecin hospitalier réfère vers le centre hospitalier régional dont il relève.

RAMED : POPULATION

- Cible théorique: faire bénéficier environ 8,5 millions de personnes économiquement faibles
- Mobilise des investissements de l'ordre de 3 milliards de dirhams au titre de l'année 2012

RAMED : POPULATION

- 35% de la population Marocaine
 - 90% de paivres et 10% de vulnérables
- 11.7 millions personnes en fin 2017
- 8,3 millions en juin 2015
- Au 31/12/2013, plus de 6 M debénéficiaires
 - 82% de pauvres (prévisions initiales de 45%);
 - Nombre moyen de bénéficiaires par foyer de 2,74;

Le RAMED: infrastructure

- L'Etat met à la disposition des bénéficiaires
 - 2.030 centres de santé
 - 111 hôpitaux provinciaux et préfectoraux,
 - 12 hôpitaux régionaux et
 - 5 Centres hospitaliers universitaires,
 - création de 80 unités médicales équipées
 - augmentation du nombre des unités médicales mobiles (602 unités de soins médicaux et 19 unités de soins dentaires).

Le RAMED: infrastructure

- Des partenariats public-privé sont prévus, notamment dans les régions peu dotées en infrastructures publiques, ou en ce qui concerne les spécialités qui connaissent une demande accrue.
- Le régime prévoit une humanisation des services
 - Création de guichet RAMED dans les hôpitaux et CS

RAMED: Financement

- le financement du Ramed a été estimé au démarrage à 3 milliards de dirhams
 - 75% à la charge de l'État,
 - 19% à la charge des personnes en situation de vulnérabilité qui contribuent au financement du Régime à raison de 120,00 DH/personne chaque année et
 - 6% à la charge des collectivités territoriales qui contribuent annuellement par 40 DH/personne en situation de pauvreté.

RAMED: Financement

- les dépenses du Ramed, dont bénéficient 6 millions de personnes, ont atteint, à fin février 2013, 1,065 milliard de dirhams,
 - 31% pour prendre en charge les affections de longue durée et des affections longues et coûteuses.
- La consommation annuelle moyenne est d'environ 650 DH/personne bénéficiaire du Ramed, soit une augmentation de 90% par rapport à 2006 (343 DH/personne).

RAMED: Financement

- généralisation du Régime d'Assistance Médicale « RAMED » a permis de réduire le paiement direct des soins par les ménages de près de 38% entre 2012 et 2014.

AMO pour les travailleurs indépendants

- Loi 98/15 publié au bulletin officiel en 2018
 - Adoption des décrets par le Conseil du Gouvernement en novembre 2021
 - Les travailleurs indépendants
 - Les salariés indépendants
 - Les personnes non salariées exerçant une activité libérale

Couverture médicale de base

AMO

Etape1: Actifs, retraités et ayant droit.

Travailleurs indépendants professions libérales
(Inaya)

Anciens résistants

Etape 2: Etudiants

Cotisation salariale et patronale
Seuil minimal de cotisation est de 70 dhs et
maximal est de 400 dhs.

Secteur public: CNOPS
Secteur privé: CNSS

ANAM

RAMED

Personnes démunies non couvertes par
un régime d'assurance maladie

Etat **75%** et collectivités locales **6%** :

Participation des bénéficiaires **19%**:

-Situation de vulnérabilité:
3767dhs<RA<5650dhs. 120 dhs/per dans la
limite de 600 dhs/ménage
-Situation de pauvreté: RA<3767 dhs
bénéficient gratuitement.

ANAM (Gestion financière du RAMED)

Paysage de l'assurance maladie au Maroc

	Assurance Maladie Obligatoire					Autres régimes		
Régime	Salariés et titulaires de pension du secteur public	Salariés et titulaires de pension du secteur privé	Etudiants	Population bénéficiant des dispositions de l'article 114-secteurs public et privé-	Travailleurs non salariés	Corps des forces armées royales	Régimes spécifiques	RAMED
Organisme gestionnaire	CNOPS	CNSS	CNOPS	Mutuelles, caisses internes et assurances privées	CNSS	Mutuelle des Forces Armées Royales	CNOPS et assurances privées	Ministère de la santé, ANAM et Ministère des finances
Population	3,1 millions	7 millions	73 473	1,5 millions	Environ 11 millions	1,3 millions	345 000	10,9 millions